

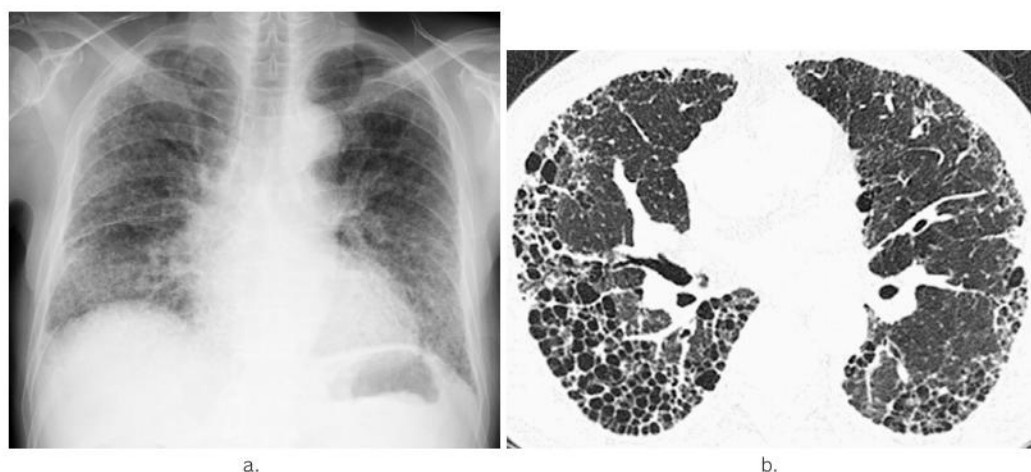


図3 生検病理組織パターンに従ったIPF画像診断
a: 胸部X線, b: HRCT

だし喫煙などによる気腫性病変を合併している場合には、疾患進行に比し肺活量の減少が軽微である場合もある。

IPFの場合、軽症・中等症では安静時動脈血酸素分圧 (PaO_2) や経皮的動脈血酸素飽和度 (SpO_2) は正常であることが多い。中等症以上になると、大半の症例で運動時低酸素がみられる。肺病変の拡がりやFVCのわりに肺拡散能の低下が著しいときや、運動時低酸素が強いときには肺高血圧の合併を評価する。一方、安静時動脈血二酸化炭素分圧 (PaCO_2) が上昇している場合には高度な進行例と考えられる。

重症度は安静時 PaO_2 と6分間歩行時 SpO_2 の組み合わせで判定する本邦独自の基準を採用している (表2)。

f 気管支肺泡洗浄 (bronchoalveolar lavage : BAL) と経気管支鏡下肺生検 (transbronchial lung biopsy : TBLB)

IPFの診断、予後推定、経過の評価にBALは必須ではないが、他疾患を除外するために有用な場合がある。なお、IPFでは、非特異性間質性肺炎 (nonspecific interstitial pneumonia : NSIP) や特発性器質性肺炎 (cryptogenic organizing pneumonia : COP) に比べ、BALの細胞分画ではリンパ球比率は正常に近い。またTBLBはIPFの診断に有用性がないため、行わないことが推奨されている。経気管支クライオ肺生検 (transbronchial lung cryobiopsy : TBLC) については、エビデンスの質は低いが、手技や結果の解釈に習熟した施設においては、SLBの代替となりうる、とガイドライン記載がアップデートされた³⁾。

g 肺生検と組織所見

SLBは、診断が確定し得ないびまん性肺疾患で、手術が禁忌でない患者に推奨される。侵襲的な検査であり、潜在的なリスクと経費を伴うため、臨床診断の精

度、得られる可能性のある情報とのバランスを考慮する必要がある (呼吸器学総論IV-10-C参照)。

IPFの病理組織は、構造改変を伴う高度な線維化病変 (ときに蜂巣肺) が、小葉間隔壁もしくは胸膜直下に認められ (図4a, b)、線維化病変と正常部の移行が急峻で線維芽細胞巣 (fibroblastic foci) (図4c, d) を伴うUIPパターンを呈する。IPF以外の疾患を示唆するalternative diagnosisパターンにみられる所見 (過敏性肺炎を示唆する肉芽腫、サルコイドーシス、膠原病肺、Langerhans細胞組織球症、NSIP、じん肺、好酸球性肺炎などに特徴的な組織所見など) がないこともIPF診断には重要な情報になる。病理組織診断が困難な場合には、間質性肺炎の知識と経験を十分に持った病理診断医の意見を求める必要がある。

治療と予後

a 治療

IPFは基本的に非可逆性に進行する疾患であり、治療は期待できない。慢性安定期の治療の目標は疾患進行抑制である。エビデンスに基づいて作成されたガイドライン^{5,6)} 上で推奨されている慢性安定期の薬物療法はpirfenidoneとnintedanibの2つの抗線維化薬に限られている。過去にIPF治療として使用されていたステロイドの単独療法や免疫抑制薬との併用療法については、有効性を支持する根拠が乏しく、逆に感染症や気胸といった合併症を増加させるため、現在では行わないことが強く推奨されている。一方、非薬物療法としては、生存率を向上させる根拠はないもののエキスパートオピニオンとして、低酸素血症を伴う場合には酸素療法が推奨されている。呼吸リハビリテーションについては、運動耐容能や生活の質の改善が得られるという研究結果から弱い推奨度で提案される (表3)。